苏州大学 · 校园用药课堂

合理用药

给宿舍药箱上堂课



药名熟悉，就能放心吃？
先学会看、核、问、记。

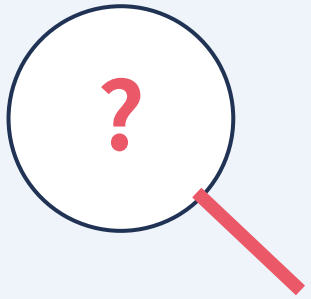
看说明书	核对成分	问清疑点	留好记录

主讲：同学甲 / 同学乙

35 分钟 · 双人展示

今天的路线：从会判断，到会行动

01



基本原则

5 分钟

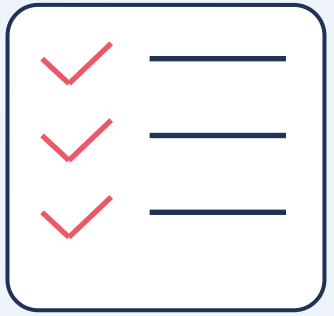
02



宿舍误区

17 分钟

03



安全用药

8 分钟

04



选择挑战

5 分钟

全程约 35 分钟，已包含举手互动。

室友感冒了，你先做哪一步？

单选

A 用上次的剩药，沿用当时吃法

B 拍清楚药盒，先核对再作决定

C 按最主要症状，先挑一盒试试



举手选择 A / B / C ｜暂不揭晓

合理用药，要同时过四关

01 安全

关注禁忌与不良反应

02 有效

针对真正需要解决的问题

03 经济

避免不必要的花费

04 适宜

适合这个人、这个时机

刚才选 B：先了解，再决定。

两盒药，是“双保险”还是撞车？



头痛还在，要不再加一盒？



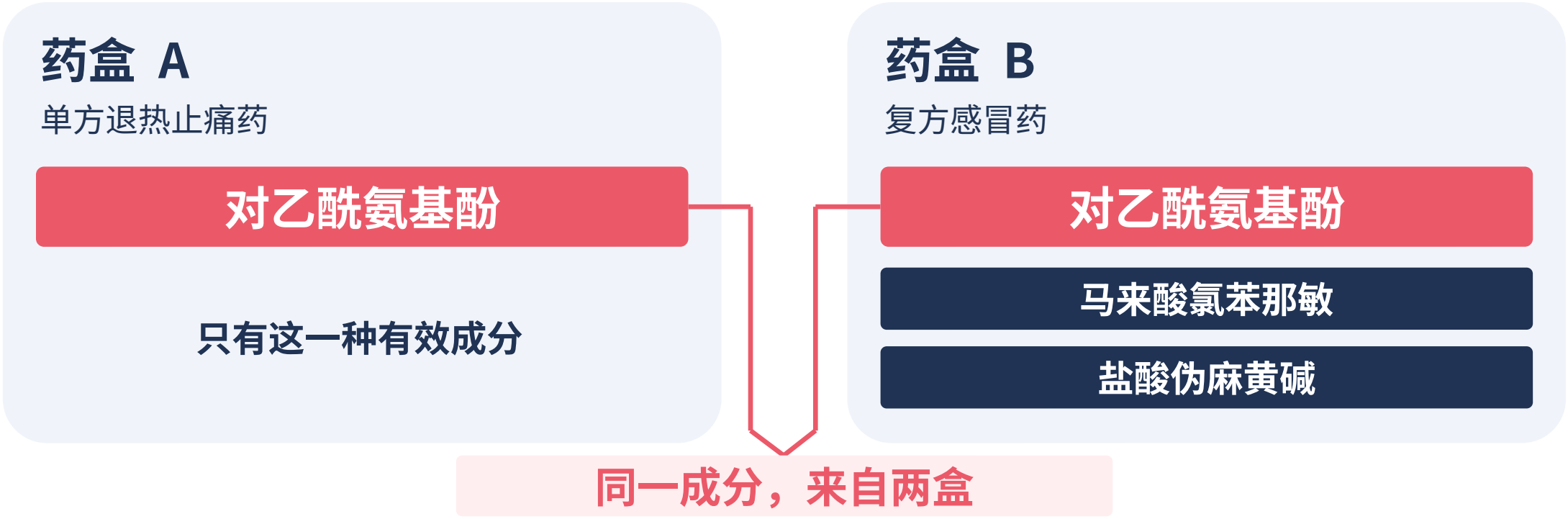
名字不同，应该不重复吧？



药盒不同，里面的成分呢？

包装不同，也可能含有同一成分。

药盒不同，成分可能“撞车”



① 圈出重复 → ② 核规格与已服情况 → ③ 未确认，不自行叠加

同名成分出现两次，是暂停核对的信号｜未确认前不自行叠加

18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

18:00

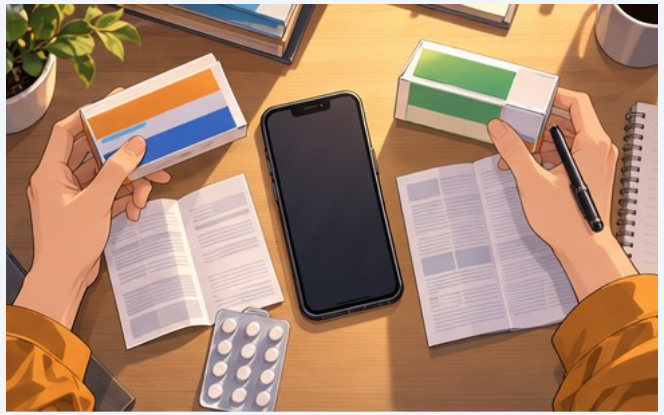


已经服过一种复方感冒药

20:00



症状还在，准备加一盒退热药



成分、规格、已服用量还没核对

成分、规格、今天吃过什么：先核清，再决定。

室友群的三条消息，你给哪条点赞?

A 拍下两盒成分，圈出相同的名字

B 按症状拆开安排，把服药时间错开

C 补上今天已服药名、规格与时间

可多选



可多选 A / B / C ｜哪些建议先帮我们补齐判断所需的信息?

答案 A + C：先把两类信息凑齐

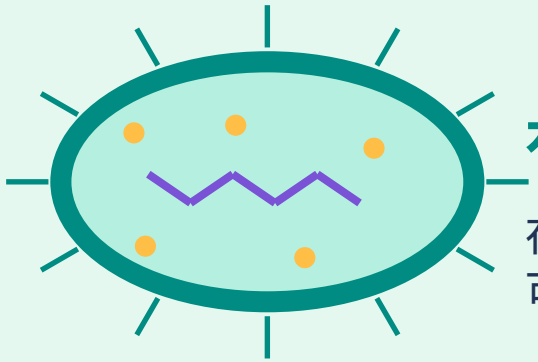
A + C

- A 圈出同名成分，发现可能重复
- C 补规格和已服记录，核对累计使用
- B 错开时间，仍不能代替完整核对

同成分先不自行叠加；拿着完整信息，再核实下一步。

案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

细菌

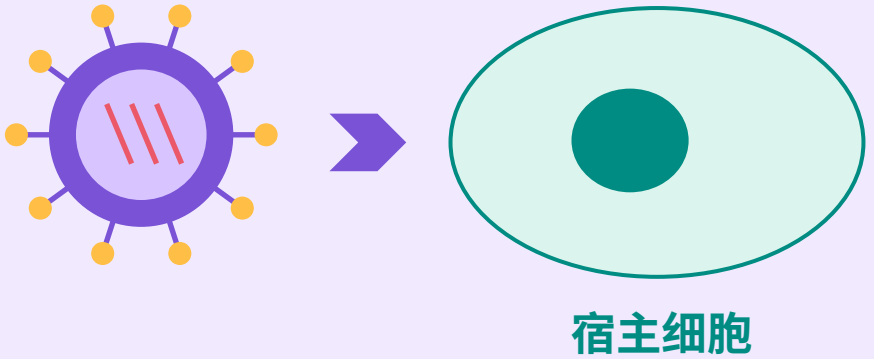


有细胞结构

在适宜条件下
可自行繁殖

某些细菌结构或过程
可成为抗生素的靶点

病毒



宿主细胞

无细胞结构
依赖宿主细胞复制

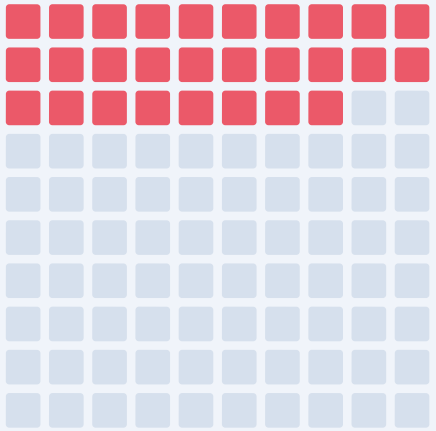
普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

不需要的抗生素，也可能带来真实伤害

美国门诊抗生素处方

至少

28%



被估计为不必要

药物副作用导致的急诊

5 次中，约 1 次

涉及抗生素反应



皮疹、腹泻，也可能严重过敏

没有治疗需要，也要承担用药风险。

把“别乱吃抗生素”，换成三个动作

01



先确认需要

感冒症状，不自动等于要用抗生素

02



不接室友剩药

相似症状，不代表同一病因

03



按处方执行

疗效或反应有疑问，及时咨询

先确认需要，再按具体处方使用；有疑问及时联系医生或药师。

案例③：鼻子舒服了，上课却犯困



终于不用一直擦鼻涕！

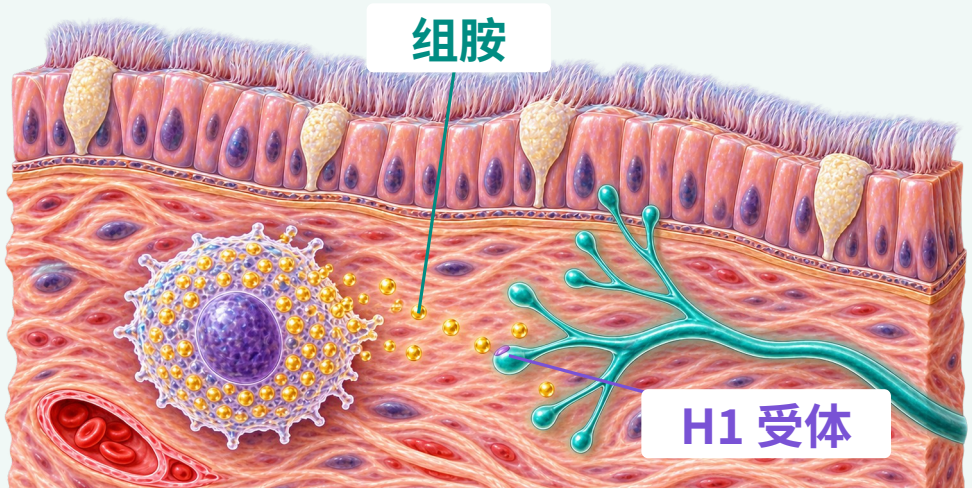


鼻子好了，脑子想“下课”……

症状缓解，也要留意精神状态与日常活动。

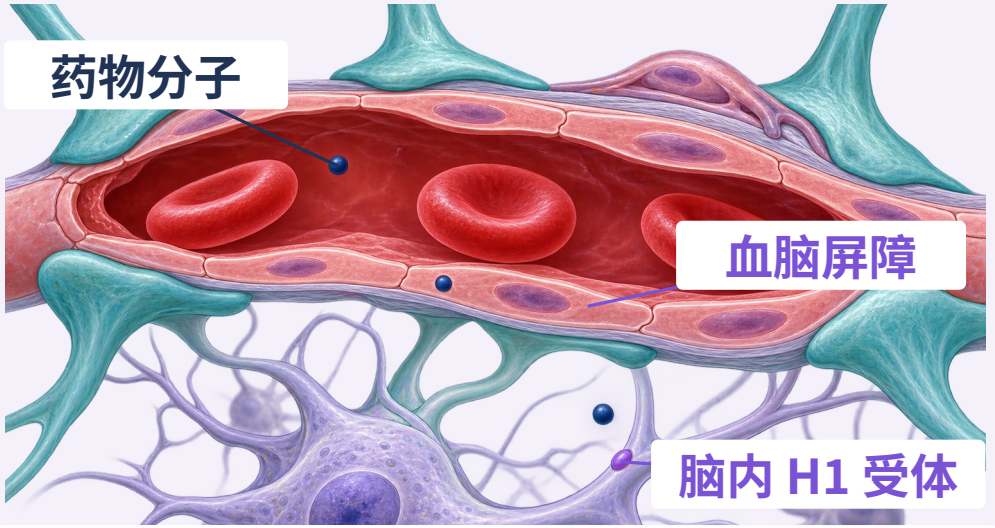
抗组胺药：为什么鼻子舒服了，人却可能困?

鼻部：缓解部分过敏症状



抗组胺药降低 H1 相关信号
可减轻鼻痒、喷嚏和流涕

脑内：可能影响清醒状态



部分药物可进入脑内
影响 H1 相关信号，可能嗜睡

缓解症状，也要留意嗜睡提示与个人反应。

聚餐邀请到了，你先回哪条消息？

A 先吃点东西，把两者错开两小时

B 照以前的经验，只小酌不碰烈酒

C 今晚先换白水，按具体药名查要求

单选



单选｜今天服过抗过敏药，具体饮酒要求未确认；下一页再揭晓。

案例④：聚餐这杯酒，先停一下



白天服过药，今晚聚餐怎么办?



室友：就喝一点，没事吧?



我先换白水，再核实这盒药的要求

刚才选 C：拿不准就先不喝；错开两小时、酒量好都不能代替核实。

从四个案例，走到四个用药动作



拿不准，先别靠感觉。

看

症状、说明书、
就医信号

核

成分、用法、禁忌
与相互作用

问

带齐信息，
问医生或药师

记

药名、时间、
用量与反应

先把信息看清，再把不确定问清。

说明书：先找能改变判断的信息

成分 / 通用名

有没有重复成分?

适应证 / 功能主治

是否适合这次情况?

用法用量

一次多少、间隔多久?

禁忌 / 注意事项

哪些情况需要避开?

相互作用 / 不良反应

其他药或酒会影响吗?

贮藏 / 有效期

现在还能否使用?



看清成分与用途，再核用法和禁忌。

核完说明书，使用方式也别随意改



用法找到了，别凭感觉改。

漏服

先查处理要求，不自行加倍

疗程

按处方执行，有问题及时咨询

剂型

缓释、肠溶等，不随意掰碎

不同药物要求不同，先核具体说明再行动。

拿不准时，把三件事告诉药师



药盒和记录，我都带来了。

哪里不舒服，已经持续多久？

用了哪些药，何时吃了多少？

有哪些过敏史、疾病或特殊情况？

带上药盒、说明书与已服记录，让咨询更准确。

出现这些信号，别继续自己试药

120
立即急救

呼吸困难、喉舌肿胀
或意识异常

疑似超量 / 误服
及时寻求医疗帮助

症状持续、加重或反复
及时就诊



带上药盒与已服记录。

严重信号优先求助，别等症状“自己好”。

药箱不求满，信息要留全



需要时，能认清、查到、说清。

保留原包装

药盒和说明书一起留

检查有效期

同时核对贮藏要求

留好用药记录

药名、时间、用量与反应

不混装，不分享处方药；记录让下次咨询更准确。

把四个案例，变成四个下一步

叠加感冒药	→	核对重复成分与已服记录
感冒想到抗生素	→	先确认是否需要
用药后困倦	→	查提示，避开高风险活动
服药后聚餐	→	先核实饮酒要求

方法已经齐了：接下来替小苏做一次选择。

综合挑战：两盒药，一场聚餐



白天吃过一种复方感冒药。



还不舒服，要加第二盒吗？



今晚聚餐，药和酒能搭吗？

症状较轻；两盒成分与饮酒要求都未核实。

小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

A 聚餐先点白水，具体饮酒要求再查

B 药盒和已服记录，一起交给药师核对

C 照上次的经验，把第二盒改到睡前

可多选



可多选：哪些安排能补齐判断所需的信息？

答案 A + B：把两条建议一起做



A 先用白水

饮酒要求未明，先不喝酒

B 带齐信息核对

两盒药和已服记录，一起问药师

C 改到睡前

仍没补齐成分与已服信息

若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

药可以常备，
判断不能省略。

看	看清说明书与实际需要
核 · 记	核对成分，留下已服记录
问	拿不准，问医生或药师



谢谢大家

会看 · 会核 · 会问 · 会记